

CAPÍTULO 7.13

Manejo del Cáncer de Tiroides

PERFIL EUNACOM 1.03.2.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Bocio

Definición

Aumento de volumen de la glándula tiroides. No implica disfunción tiroidea.

Clasificación según función

TABLA 7.13.1: TIPO VS TSH

TIPO	TSH	T4 LIBRE	CAUSA EJEMPLO
Eutiroideo	Normal	Normal	Bocio simple, deficiencia de yodo
Hipotiroideo	↑	↓	Hashimoto, déficit de yodo
Hipertiroideo	↓	↑	Graves, bocio multinodular tóxico

Causas

- **Déficit de yodo** → causa más frecuente mundial de bocio
- **Tiroiditis de Hashimoto** (autoinmune)
- **Enfermedad de Graves-Basedow**
- **Bocio multinodular** (simple o tóxico)
- Fármacos bociógenos: litio, amiodarona

Estudio

- **TSH** → define si hay disfunción
- **Ecografía tiroidea** → tamaño, estructura, nódulos
- Si hay nódulos → seguir algoritmo del **nódulo tiroideo** (TI-RADS + PAAF si corresponde)

Tratamiento

- Tratar la causa de la disfunción (si la hay)
- Bocio eutiroideo simple: observar; si hay síntomas compresivos → considerar cirugía

- Déficit de yodo → yoduro de potasio o sal yodada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 38 años operada de tiroidectomía total por nódulo tiroideo. La biopsia definitiva informa Carcinoma Papilar de Tiroides de 2.5 cm con invasión capsular y 2 ganglios linfáticos metastásicos en compartimento central (pT2 N1a M0)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo del Cáncer Papilar de Tiroides: subtipo más frecuente (85-90%) y de excelente pronóstico. En pacientes con tumores > 2-4 cm o metástasis ganglionares (riesgo intermedio/alto), el tratamiento complementario incluye: (1) Ablación de remanente tiroideo con Yodo Radiactivo (I-131); (2) Terapia supresiva con Levotiroxina (meta TSH < 0.1 mUI/L); (3) Seguimiento con Tiroglobulina sérica (marcador tumoral) y ecografía cervical periódica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Papilar (85%) + folicular (10-15%) = cáncer diferenciado. Mismo manejo: tiroidectomía total + levotiroxina supresiva + yodo radioactivo.
- Objetivo TSH en cáncer: 0,1-0,4 (bajo riesgo) o <0,1 (alto riesgo). Más suprimido que en hipotiroidismo normal.
- Seguimiento del diferenciado: tiroglobulina + TSH + ecografía.
- Cáncer medular: células C, asociado a NEM 2. ANTES de operar: descartar feocromocitoma con metanefrinas urinarias.
- Cáncer medular NO responde a yodo radioactivo. Seguimiento con calcitonina.
- Cáncer anaplásico: mal pronóstico, tratamiento principalmente paliativo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DEL CÁNCER DE TIROIDES)

PREGUNTA 1

Paciente con cáncer medular de tiroides confirmado por PAAF. ¿Cuál es el examen que se debe solicitar ANTES de la tiroidectomía?

- A) Tiroglobulina sérica
- B) Cintigrafía con yodo radioactivo
- C) Metanefrinas y catecolaminas en orina
- D) TSH y T4 libre
- E) PET-CT

RESUMEN: MANEJO DEL CÁNCER DE TIROIDES

El cáncer de tiroides se diagnostica mediante PAAF en contexto del estudio del nódulo tiroideo. Histología: papilar (85%, más frecuente y mejor pronóstico), folicular (10-15%). Ambos = cáncer diferenciado. Manejo: tiroidectomía total + levotiroxina (supresiva con TSH objetivo 0,1-0,4, o <0,1 si alto riesgo) + yodo radioactivo (captan yodo). Seguimiento con tiroglobulina + TSH + ecografía. Cáncer medular (5%): células C/parafoliculares, asociado a NEM tipo 2. Antes de operar: pedir metanefrinas/catecolaminas urinarias para descartar feocromocitoma. No responde a yodo radioactivo. Seguimiento con calcitonina. Cáncer anaplásico: mal pronóstico, tratamiento paliativo.